

Session d'information CHIPS - FR

Indicateurs de qualité Prévention des infections

12/03/2026



Volksgezondheid
Veiligheid van de Voedselketen
Leefmilieu



Accords pratiques concernant le webinar

- **Programme**
 - 20 min – Présentation sur CHIPS
 - 20 min - Démonstration de la plateforme PCI
 - 20 min – Questions-réponses
- **Pendant les présentations**
 - Veuillez garder votre microphone en mode silencieux
 - Utilisez le chat le moins possible
- **Questions**
 - Les questions seront traitées après les deux présentations
 - Veuillez lever la main pour poser vos questions
 - Utilisez le chat le moins possible
- **L'enregistrement sera mis à disposition**

CHIPS

*“Check
Hospital
Infection Prevention
Status”*



Objectif du webinaire et programme

Objectif du webinaire

- Expliquer le fonctionnement de CHIPS
- Expliquer le fonctionnement de l'outil
- Clarifier les attentes envers les équipes PCI
- Répondre aux questions

Présentation du webinaire

- Introduction et objectif
- Validation 2025
- Principes importants
- Structure CHIPS
- Notation (vert/jaune/orange)
- Indicateurs
- Rapport et validation des données saisies
- Soutien national
- Calendrier
- Plateforme PCI

Introduction et objectif CHIPS

- = Une version actualisée des indicateurs de qualité PCI
- = Outil national de surveillance de la PCI dans les hôpitaux belges de soins aigus
- **Développé par** la Plateforme fédérale pour la PCI – Groupe de travail CHIPS ; équipe PCI de Sciensano ; équipe de soutien BAPCOC
- **Objectif de CHIPS : renforcer les programmes PCI**
 - Au niveau hospitalier :
 - Donner un aperçu pragmatique des pratiques PCI,
 - Soutenir la réflexion et la planification internes
 - Au niveau national :
 - Permettre un suivi standardisé de la PCI
 - Soutenir l'élaboration de politiques

→ Double rôle du CHIPS : outil de suivi et outil d'amélioration

Validation CHIPS 2025

- 57 hôpitaux ont participé
- Nous avons analysé :
 - Entretiens
 - Séances de réflexion à voix haute
 - Questions ouvertes de l'enquête
 - Les commentaires envoyés par e-mail
 - Scores IPCAF
 - Fiabilité interobservateurs (concordance entre les évaluateurs)
- À vérifier :
 - Validité
 - Fiabilité
 - Faisabilité

Résultats de la validation 2025

Fiabilité

- La fiabilité interobservateurs du CHIPS était globalement moyenne
- Variation entre les indicateurs et les thèmes
- Moins de concordance dans les domaines de la formation, du suivi, de la surveillance et de la hiérarchisation

Validité

- Association forte et statistiquement significative entre les scores CHIPS et IPCAF
- Les professionnels de la PCI ont jugé CHIPS utile pour la réflexion et la politique

Valeur ajoutée selon les équipes PCI

- Aide à structurer le programme PCI
- Soutient l'élaboration de politiques et de plans d'action
- Facilite le dialogue avec la direction

Défis

- L'outil est complexe et relativement long
- Interprétation difficile de certains indicateurs
- Toutes les activités PCI ne sont pas couvertes
- Difficile d'obtenir une note verte pour tous les thèmes en 3 ans

Visites entre pairs

- Très appréciées pour les échanges et l'apprentissage entre hôpitaux

CHIPS Principes importants

- La PCI est considéré comme une **responsabilité de l'ensemble de l'hôpital**, et pas seulement de l'équipe PCI.
- **Toutes les tâches de l'équipe et du comité PCI** n'y sont **pas** intégrées
- **Outil dynamique** qui évoluera au fil du temps
- Encourage le passage d'une approche principalement réactive à une **approche préventive** structurée
- Encourage **l'utilisation active des résultats de la surveillance et du suivi pour planifier, mettre en œuvre et suivre les actions d'amélioration** : aligné sur le cycle Plan-Do-Check-Act (PDCA)
- Basé sur une **stratégie multimodale** : procédures, formation, mesure et retour d'information

Plan (planifier)	Les hôpitaux déterminent leurs priorités sur la base de leurs plans à l'échelle de l'établissement et de leur analyse des risques, et élaborent des plans pour la formation, le suivi, la surveillance et le retour d'information, ainsi que d'autres mesures d'amélioration.
Do (faire)	Les hôpitaux mettent en œuvre des actions concrètes via une stratégie multimodale , comprenant des procédures actualisées, des formations, des audits, etc.
Check (vérifier)	Les résultats du suivi, de la surveillance et du retour d'information sont évalués.
Act (agir)	Les résultats sont intégrés dans le plan d'amélioration ou repris dans une analyse des risques pour un suivi ultérieur.

CHIPS Principes importants

- **Adaptable au contexte hospitalier propre à chaque hôpital**
 - Conçu pour s'adapter au contexte local
 - Tient compte :
 - Priorités locales
 - Profils de risque
 - Maturité du programme PCI
- Basé sur **les plans propres à chaque hôpital**
 - L'évaluation part des plans existants, tels que :
 - Plans de formation
 - Plans de suivi
 - Plans stratégiques ou plans d'action

Structure CHIPS

35 indicateurs répartis sur 10 thèmes PCI
2 à 4 indicateurs par thème

Pour chaque thème, on évalue si

- ☐ Les procédures sont-elles à jour ?
- ☐ Des formations sont dispensées
- ☐ Des activités de suivi et/ou de surveillance et de retour d'information sont menées

Objectif : chaque thème doit être au moins une fois dans le vert au cours d'un cycle de trois ans.

Thèmes	Indicateurs	Résultat		
Personnel et environnement favorable	Effectifs IPC Référénts IPC Effectifs hospitaliers Chambres individuelles			
Hygiène des mains	Procédures Formation et éducation Suivi, audit et retour d'information			
Nettoyage de l'environnement et des équipements	Procédures Formation et éducation Surveillance, audit et retour d'information			
Précautions et dépistage liés à la transmission (MDR)O	Procédures Formation et éducation Suivi, audit et retour d'information			
Prévention des infections liées aux cathéters centraux (CLABSI)	Procédures Formation et éducation Suivi et retour d'information sur les bundles de soins Surveillance et retour d'information			
Prévention des infections urinaires associées à un cathéter (CAUTI)	Procédures Formation et éducation Suivi et retour d'information sur les bundles de soins Surveillance et retour d'information			
Prévention nv-HAP	Procédures Formation et éducation Suivi et retour d'information sur les bundles de soins Surveillance et retour d'information			
Prévention VAP	Procédures Formation et éducation Suivi et retour d'information sur les bundles de soins Surveillance et retour d'information			
Prévention des infections du site opératoire	Procédures Formation et éducation Suivi et retour d'information sur les bundles de soins Surveillance et retour d'information			
Implication des parties prenantes	Implication des patients Implication de la direction			

Système de notation

- **Un seul niveau de performance** est **choisi** pour chaque indicateur
- Tous les critères d'un niveau doivent être remplis pour atteindre un niveau supérieur
- **Trois niveaux**
 - Vert** – bonne mise en œuvre / atteint
 - Jaune** – partiellement atteint / amélioration nécessaire
 - Orange** – mise en œuvre insuffisante / points importants à améliorer
- CHIPS est évalué **par numéro d'agrément de l'hôpital**, **incluant** tous les sites
- Le score de l'indicateur est basé sur le **site ayant obtenu le score le plus bas**
- **Score par thème**
 - Les indicateurs sont combinés pour former un score global pour les différents thèmes
 - Comment obtenir un **score vert** par **thème** ?
 - Thèmes avec 2 indicateurs : les deux indicateurs sont verts
 - Thèmes comportant 3 indicateurs : les trois indicateurs sont verts
 - Thèmes comportant 4 indicateurs : les indicateurs « procédures » et « formation et éducation » sont verts et au moins un des indicateurs « suivi » ou « surveillance » est vert

Dotation et environnement facilitateur

Niveau	Personnel PCI
Orange	< 1 ETP Personnel PCI (infirmier PCI ou médecin PCI) pour 250 lits sous responsabilité
Jaune	1 ETP personnel PCI (infirmier PCI ou médecin PCI) pour 150 à 250 lits sous responsabilité
Vert	> 1 ETP de personnel PCI (infirmier PCI ou médecin PCI) pour 150 lits pris en charge

Remarque : le niveau vert reflète un niveau de dotation en personnel supérieur aux exigences minimales prévues par la législation belge et récompense les hôpitaux qui ont investi dans le renforcement de leurs capacités en matière de prévention et de contrôle des infections.

Niveau	Référents PCI
Orange	Pas de référents PCI actifs
Jaune	Référents PCI présents, mais pas dans tous les départements
Vert	Référents PCI présents dans tous les services

Niveau	Effectifs hospitaliers
Orange	Le ratio I/P est fixé et basé sur des normes historiques. L'intensité des soins n'est pas évaluée et n'a aucune influence sur les effectifs.
Jaune	Le ratio I/P est ajusté en fonction de l'intensité des soins, mais : • l'intensité des soins n'est pas évaluée de manière systématique, et/ou • les ajustements ne sont pas appliqués de manière structurelle.
Vert	Le rapport I/P est ajusté en fonction de l'intensité des soins, et : • l'intensité des soins est évaluée systématiquement, et/ou • les ajustements sont appliqués de manière structurelle.

Indicateur : évalue dans quelle mesure le ratio infirmière-patient est adapté en fonction de l'intensité des soins. À remplir en concertation avec la direction de l'hôpital.

Remarque : l'indicateur est encore en cours d'élaboration et peut être adapté sur la base des informations fournies par les hôpitaux concernant la mesure de l'intensité des soins.

Niveau	Chambres individuelles
Orange	% de chambres individuelles par rapport au nombre total de chambres ≤ 25 %
Jaune	% de chambres individuelles par rapport au nombre total de chambres entre 25 % et 60 %
Vert	% de chambres individuelles par rapport au nombre total de chambres ≥ 60 %

Huit thèmes PCI

- ☐ Hygiène des mains
- ☐ Nettoyage de l'environnement et du matériel
- ☐ Mesures de précaution axées sur la transmission et pratiques de dépistage
- ☐ Prévention CLABSI, CAUTI, VAP, nv-HAP, SSI

Niveau	Procédures
Orange	Aucune procédure n'est en place, ou une procédure est en place mais n'a pas été révisée ou mise à jour au cours des 5 dernières années.
Jaune	Une procédure actualisée ou révisée (au cours des 5 dernières années) est disponible, mais n'est pas accessible au personnel soignant et hospitalier concerné pour sa mise en œuvre.
Vert	Une procédure actualisée ou révisée (au cours des 5 dernières années) est disponible et accessible au personnel soignant et hospitalier concerné pour sa mise en œuvre.

Niveau	Formation et éducation
Orange	Il n'existe pas de plan de formation sur « le sujet » pour l'intégration et la formation continue (même si des formations sont dispensées).
Jaune	Il existe un plan de formation pour l'intégration et la formation continue sur « le sujet » : • révisé ou actualisé au cours des 5 dernières années • avec une formation multiméthode (≥ 3 méthodes) • avec un groupe cible défini (personnel soignant et hospitalier concerné) et la formation d'intégration sur « le sujet » est dispensée conformément au plan ou la formation continue sur « le sujet » est dispensée conformément au plan.
Vert	Il existe un plan de formation pour l'intégration et la formation continue sur « le sujet » : • révisé ou actualisé au cours des 5 dernières années • avec une formation multiméthode (≥ 3 méthodes) • avec un groupe cible défini (personnel soignant et hospitalier concerné) et la formation d'intégration sur « le sujet » est dispensée conformément au plan et la formation continue sur « le sujet » est dispensée conformément au plan.

Indicateurs PCI par thèmes

- ☐ Hygiène des mains
- ☐ Nettoyage de l'environnement et du matériel
- ☐ Mesures de précaution axées sur la transmission et pratiques de dépistage
- ☐ Prévention CLABSI, CAUTI, VAP, nv-HAP, SSI

Niveau	Surveillance et retour d'information
Orange	Les audits sur la mise en œuvre des mesures ne sont pas effectués ou le retour d'information n'est pas communiqué à tous les membres du personnel soignant et hospitalier concernés.
Jaune	Des audits sur la mise en œuvre des mesures sont effectués et un retour d'information est fourni à tous les professionnels de santé et hospitaliers concernés.
Vert	Des audits sur la mise en œuvre des mesures sont effectués, un retour d'information est fourni à tous les membres du personnel soignant et hospitalier concernés, et les résultats sont intégrés dans un plan d'amélioration ou documentés dans une analyse des risques.

Remarque :

Spécificités pour
Hygiène des mains et nettoyage de
l'environnement

Pour les infections associées aux soins :
BUNDLES de soins ≠ listes de contrôle

Suivi et retour d'information
OU
Surveillance et retour
d'information

Niveau	Surveillance et retour d'information
Orange	La surveillance n'est pas effectuée, ou le retour d'information n'est pas communiqué à tous les professionnels de santé et membres du personnel hospitalier concernés.
Jaune	La surveillance est effectuée et un retour d'information est fourni à tous les professionnels de santé et hospitaliers concernés.
Vert	La surveillance est effectuée, un retour d'information est fourni à tous les professionnels de santé et hospitaliers concernés, et les résultats sont intégrés dans un plan d'amélioration ou documentés dans une analyse des risques.

Implication des parties prenantes

Niveau	Patients
Orange	Les patients ne sont pas impliqués dans les activités IPC.
Jaune	Une politique à l'échelle de l'hôpital vise à garantir que les patients soient informés des risques d'infection et des mesures de base en matière de prévention et de contrôle des infections.
Vert	Il existe une politique à l'échelle de l'hôpital visant à informer les patients sur les risques d'infection et les mesures de base en matière de prévention et de contrôle des infections, et les patients sont activement encouragés à participer à la prévention et au contrôle des infections pendant leur prise en charge.

Niveau	Direction
Orange	La direction de l'hôpital (direction médicale et infirmière) ne participe pas aux comités de prévention et de contrôle des infections.
Jaune	La direction de l'hôpital (direction médicale et infirmière) participe à au moins 4 réunions du comité IPC par an.
Vert	La direction de l'hôpital (direction médicale et infirmière) participe à au moins 4 réunions du comité IPC par an, et l'IPC est formellement ancré dans le plan stratégique/médical à l'échelle de l'hôpital, avec un soutien et une responsabilité clairs de la part de la direction.

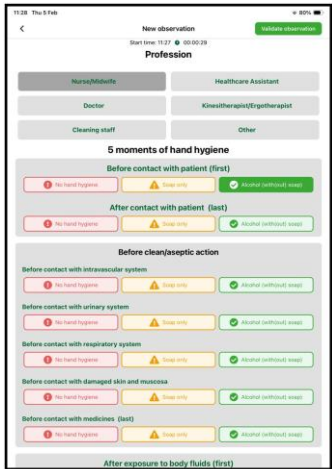
Rapport et validation externe

Rapport interne

- **2026** – Début du rapport CHIPS pour tous les hôpitaux – année de validation
 - Auto-rapportage par les hôpitaux
 - Validation externe des données dans une sélection aléatoire d'hôpitaux (Sciensano & BAPCOC Support Team)
 - Rapport agrégé
 - Données sont partagées avec BAPCOC
- **À partir de 2027** – Après validation complète
 - La validation externe des données saisies se poursuivra dans une sélection aléatoire d'hôpitaux
 - Les résultats des hôpitaux seront rendus publics, avec une contextualisation correcte
 - Rapport sur les meilleures pratiques, avec des exemples d'hôpitaux par thème

Soutien national via le NAP AMR 2026-2030

- **Outils généraux – par le groupe de travail CHIPS**
 - Modèles de plan de formation, d'analyse des risques, de plan stratégique, etc.
- **Boîte à outils en ligne – par l'équipe de support BAPCOC**
- **Directives – par le CSS**
 - Mise à jour sur le nettoyage de l'environnement CSS (prévue pour 2027)
 - Nv-HAP (prévu pour 2029)
- **Formations – par l'équipe de support BAPCOC**
 - Développement de modules d'apprentissage en ligne et de matériel de formation
- **Suivi et retour d'information – par Sciensano avec la Plateforme fédérale**
 - Élaboration de programmes de soins CLABSI, CAUTI, SSI, VAP, nv-HAP
 - Outil de suivi et de retour d'information pour
 - l'hygiène des mains (2026)
 - Bundles de soins (2026)
 - Nettoyage de l'environnement (2027)



Thèmes	Indicateurs
Hygiène des mains	Procédures Formation et éducation Suivi, audit et retour d'information
Nettoyage de l'environnement et des équipements	Procédures Formation et éducation Surveillance, audit et retour d'information
Précautions et dépistage liés à la transmission (MDR)O	Procédures Formation et éducation Suivi, audit et retour d'information
Prévention des infections liées aux cathéters centraux (CLABSI)	Procédures Formation et éducation Suivi et retour d'information sur des bundles de soins Surveillance et retour d'information
Prévention des infections urinaires associées à un cathéter (CAUTI)	Procédures Formation et éducation Suivi et retour d'information sur des bundles de soins Surveillance et retour d'information
Prévention nv-HAP	Procédures Formation et éducation Suivi et retour d'information sur des bundles de soins Surveillance et retour d'information
Prévention VAP	Procédures Formation et éducation Suivi et retour d'information sur des bundles de soins Surveillance et retour d'information
Prévention des infections du site opératoire	Procédures Formation et éducation Suivi et retour d'information sur des bundles de soins Surveillance et retour d'information

Dans le cadre du projet AIM

- Visites entre pairs comme élément lié au financement supplémentaire dans le projet AIM

Pour tous les hôpitaux (indépendamment de l'AIM)

- Les indicateurs de qualité PCI – CHIPS – restent une obligation légale, indépendamment de la participation au projet AIM
- Transparence pour tous les hôpitaux, indépendamment de leur participation au projet AIM

Calendrier des prochaines étapes en 2026

Étape	Qui ?	Description	Calendrier
Fiabilité interobservateur	Tous les hôpitaux	Deux membres de l'équipe PCI remplissent le questionnaire de manière indépendante et sans se concerter via LimeSurvey.	Lien ouvert : 13/03/2026 – 31/03/2026
Remplir CHIPS dans la plateforme PCI	Tous les hôpitaux	L'équipe PCI remplit le questionnaire CHIPS de manière consensuelle via la plateforme PCI.	01/04/2026 – 30/04/2026
Visites entre pairs	Hôpitaux participant au projet AIM	Les participants à l'AIM confirment leur participation. Ils indiquent ensuite les hôpitaux qu'ils souhaitent visiter. Un planning des visites est établi sur cette base.	Visites entre pairs entre 01/06/2026 – 30/09/2026
Validation externe	Tous les hôpitaux	Une sélection aléatoire d'hôpitaux est visitée afin de valider les données saisies. Cette opération est indépendante des visites entre pairs.	Calendrier à venir